

Module de Gastro-Entérologie

LES TUMEURS BÉNIGNES DU FOIE

Pr Choubar M.S

Année 2025/2026

Objectifs Pédagogiques

- Reconnaître l'entité des tumeurs bénignes du foie
- Faire le diagnostic des tumeurs bénignes du foie
- Proposer une prise en charge adéquate

I. INTRODUCTION

Les tumeurs bénignes du foie sont un groupe hétérogène de lésions avec différentes origines cellulaires, . Ces lésions sont fréquemment découvertes de façon fortuite en raison de l'utilisation généralisée des examens d'imagerie et ont souvent une évolution bénigne. Celles-ci comprennent

- L'hémangiome hépatique
- L'hyperplasie nodulaire focale (HNF)
- L'adénomes hépatocellulaire (AH).
- Le kyste biliaire

L'Hémangiome Hépatique

Un angiome, aussi appelé hémangiome, du foie désigne une tumeur bénigne hépatique de type non épithélial qui se développe à partir des vaisseaux sanguins. Ces petites lésions sont fréquentes dans la population puisqu'elles concernent 2 à 5% des individus.

Les angiomes du foie concernent toute la population et tous les âges, cependant ils sont plus fréquents chez les femmes (2 cas sur 3).

Les hémangiomes hépatiques sont souvent de petite taille (< 4 cm) et uniques, bien qu'ils puissent atteindre une taille de 20 cm de diamètre. Même quand ces lésions sont de très grande taille « hémangiomes géants ».

La pathogenèse de l'hémangiome n'est pas bien connue, peut être liée à un trouble congénital avec une éventuelle dépendance hormonale

DIAGNOSTIC

- La plupart des patients sont asymptomatique
- Les hémangiomes sont généralement découvertes de façon fortuite
- Une douleur abdominale non spécifiques
- Les hémangiomes mesurant 10 cm ou plus, dénommés « hémangiomes géants » peuvent être symptomatiques, incluant une douleur et des stigmates du syndrome de Kasabach-Merritt (SKM) caractérisé par une réaction inflammatoire et une coagulopathie.
- Le bilan biologique hépatique est souvent normal
- L'échographie est souvent l'examen de dépistage de ces lésions et fait le diagnostic lorsque la lésion est hyperéchogène, située le long de la veine sus hépatiques avec un renforcement postérieur ou en périphérie du foie.
- Le diagnostic est plus difficile lorsqu'il existe des remaniements intra-lésionnels et on devra recourir à des examens après injection de produit de contraste, il s'agit en effet d'un remplissage lent, centripète en mottes.
- L'IRM augmente la spécificité dans le diagnostic en mettant en évidence un signal hyper intense en T2.

4)Complications : elles sont rares

- Rupture spontanée ou post-traumatique avec hémopéritoine

- Gêne mécanique
- Syndrome de Kasabach-Merritt (SKM) caractérisé par une réaction inflammatoire et une coagulopathie.

TRAITEMENT

- Abstention thérapeutique ++++
- Pas de surveillance particulière.
- Exérèse chirurgicale en cas d'angiome compliqué.

ADENOME DU FOIE

Les adénomes hépatiques sont des tumeurs bénignes constitués d'hépatocytes bien différenciés sans espace porte complètement constitué

De fins vaisseaux sont habituellement observés dans l'ensemble de la tumeur

Cette tumeur est rare (prévalence estimée à 0,1 %). Elle est très rare favorisée par la prise prolongée de contraceptifs oraux.

Leur diamètre varie d'un patient à l'autre, de quelques millimètres à plus de 10 cm

Ils sont beaucoup plus fréquents chez la femme avec un sexe-ratio de 10 :1.

DIAGNOSTIC CLINIQUE

L'âge au diagnostic est habituellement de 30 à 40 ans chez des femmes sous des contraceptifs oraux dans 60 à 90% des cas.

Le plus souvent asymptomatique, parfois elle est à l'origine d'une douleur à type de pesanteurs ou d'une hépatomégalie lorsque le nodule est de grande taille.

Une douleur aigue de l'hypochondre droit peut s'observer en cas d'hémorragie intra-tumorale.

DIAGNOSTIC PARA-CLINIQUE

- Le bilan biologique hépatique et l'alpha foeto-proteine sont normaux
- A l'échographie, c'est une tumeur arrondie, bien limitée plus ou moins hétérogène, hyperéchogène.
- Au scanner : c'est une zone hypodense ou isodense, après injection de produit de contraste l'opacification est précoce, mais souvent hétérogène.
- L'imagerie par résonnance magnétique : est l'examen de référence devant une suspicion d'adénome hépatocellulaire. Elle montre Lésion hétérogène Iso ou hyperintense en T1 Hyperintense en T2, Hypervascularisée de façon variable au temps artériel

La biopsie : discutée au cas par cas. Néanmoins, c'est l'examen de référence pour le diagnostic des adénomes hépatocellulaires et orientant soit vers la chirurgie soit vers une surveillance.

COMPLICATIONS :

Hémorragie intra tumorale

Transformation maligne +++

TRAITEMENT

- AHC : très faible risque de complication. Surveillance (possible par échographie) à privilégier avec discussion de résection chez l'homme et/ou en cas de taille en augmentation et supérieure à 5 cm.
- Ailleurs :
 - Arrêt de la contraception orale,
 - Prise en charge d'une éventuelle surcharge pondérale,
 - Limitation consommation alcool.
 - Décision de résection dépend de la taille (5 cm), de la localisation de la cinétique de croissance, de l'âge de découverte

Quelles sont les modalités de surveillance ?

Une imagerie doit être répétée à 6 mois et, si la lésion est stable ou décroît de taille, être répétée à un an. Si la lésion augmente en taille ou change de caractéristiques, le dossier doit être rediscuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (biopsie, réduire l'intervalle de surveillance ou chirurgie).

HYPERPLASIE NODULAIRE FOCALE

L'HNF est typiquement une masse unique, bien circonscrite, non encapsulée, avec une cicatrice centrale fibreuse, qui contient des vaisseaux artériels dystrophiques. L'apport sanguin est exclusivement artériel

C'est une tumeur rare atteignant électivement la femme en période d'activité génitale.

DIAGNOSTIC

L'HNF est habituellement asymptomatique, donc de découverte fortuite

Parfois découverte à l'occasion à l'occasion de douleurs abdominales peu spécifiques ou d'une douleur en projection d'une grosse tumeur. L'évolution est parfaitement bénigne

Le bilan biologique est normal

A l'imagerie, la tumeur se distingue souvent mal du parenchyme avoisinant, que ce soit par l'échographie (plutôt hypoéchogène), le scanner (plutôt hypodense), ou l'IRM (plutôt hyperintense sur les séquences pondérées en T2).

Il n'y a aucun risque de transformation maligne.

L'hyperplasie nodulaire focale ne nécessite aucun traitement ni aucune surveillance.

KYSTE BILIAIRE

DEFINITION :

c'est une cavité liquidienne pure dont la paroi, faite d'une couche unicellulaire d'épithélium biliaire, est invisible à l'imagerie avec ou sans injection de produit de contraste vasculaire. La cavité ne communique pas avec l'arbre biliaire. Le liquide kystique est parfaitement limpide : il ne contient ni cellule ni bilirubine.

Les kystes biliaires simples sont parfois multiples bien qu'en nombre limité (< 5).

Lorsqu'ils sont multiples, il s'agit d'une polykystose hépatique ou d'une polykystose hépatorénale, qui sont des affections héréditaires.

DIAGNOSTIC :

Établi sur les données de l'imagerie

– le contenu du kyste apparaît

- Parfaitement homogène parfaitement anéchogène avec un renforcement postérieur des échos
- Hypodense sur les images de tomodensitométrie sans injection,
- Fortement hyperintense sur les séquences d'IRM pondérées en T2

– il n'y a pas de paroi décelable avant ou après injection de produit de contraste et la limite avec le parenchyme hépatique est parfaitement régulière.